MEDIZINISCHES LABOR BREMEN

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH
Haferwende 12 · 28357 Bremen · Tel.: +49 (0) 421 2072-0 · Fax: +49 (0) 421 2072-167 · www.mlhb.de · info@mlhb.de

Dr. med. A. Gerritzen
Facharzt für Laboratoriumsmedizin
Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
Ärztlicher Leiter

Dr. med. A. Sputtek
Facharzt für Laboratoriumsmedizin
Facharzt für Transfusionsmedizin

Dr. med. V. Heisig
Facharzt für Laboratoriumsmedizin

Dr. med. S. Krell
Facharzt für Laboratoriumsmedizin
Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
Facharzt für Immunologie
Bluttransfusionswesen

Laura Maria Rodriguez
Fachärztin für Laboratoriumsmedizin
Fachärztin für Innere Medizin

Dr. med. D. Jacobsen
Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie

Teilbefund

Auftr.-Nr.: BP ZD01 1528

Patient: **BÖKER, MARCO**
geb.: 11.07.1981 M
Kasse: Privat

Material: NAF-BLUT,2xSERUM,EDTA
Entnommen: 01.04.26 11:00
Eingang: 01.04.26 11:05
Ausgang: 01.04.26
Ihre Nr.: **7705401316**

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH · Haferwende 12 · 28357 Bremen

B2C

B2C STARNET - Direktlabor
(MLHB)
Haferwende 12

28357 Bremen

LANR: 000000000 Kopie an an Patient

Bestimmung	Resultat			Referenzbereich
B l u t b i l d				
Leukozyten	6.1	G/L	Männer	3.7 - 9.9
Erythrozyten	4.75	T/L	Männer	4.4 - 5.9
Hämoglobin	14.9	g/dL	Männer	13.5 - 17.8
Hämatokrit	0.45	L/L	Männer	0.40 - 0.53
MCV	94	fL	Erwachsene	80 - 96
HbE (MCH)	31	pg	Erwachsene	28 - 33
MCHC	33	g/dL	Erwachsene	33 - 36
Thrombozyten	306	G/L	Männer	146 - 328
HbA1c i. B.	5.1	%		4.8 - 5.9

entspricht 32 mmol HbA1c / mol (HbA0 + HbA1c)
Referenzbereich laut Herstellerangabe. Aktuelle Empfehlungen z.B. von der Deutschen Diabetes Gesellschaft können davon abweichen.
HbA1c-Werte von 5.7 - 6.4 % bergen ein Risiko zur Entwicklung von Diabetes mellitus, wobei patientenspezifische Einflussgrößen zu berücksichtigen sind. Bei Erwachsenen mit Typ 1-Diabetes sollte ein HbA1c-Wert ≤ 7,5 % angestrebt werden, wenn dies nicht durch häufigere Hypoglykämien erkauft wird. Bei Typ 2-Diabetikern werden HbA1c-Werte von 6,5 - 7,5 % zur Prävention von Folgekomplikationen und Vermeidung von schweren Hypoglykämien angestrebt.

GOT (ASAT)	67	* U/L		10 - 50
GPT (ALAT)	105	* U/L		10 - 50

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt schon bei geringer GPT-Erhöhung eine gezielte Hepatitis-C-Abklärung (HCV-Antikörper). Schätzungen zufolge bleibt über die Hälfte der HCV-Infektionen in Deutschland unentdeckt und damit unbehandelt.

γ-GT	36	U/L		10 - 71
Harnsäure i. S.	3.7	mg/dL		3.4 - 7.0
Cystatin C i. S.	folgt	mg/L	Erwachsene	0.56 - 0.99
Glukose i. B.	88	mg/dL		< 100

Die Inhibition der Glykolyse durch NaF ist erst nach einer Latenzzeit von etwa einer Stunde nach Probengewinnung vollständig.

´Außerhalb der Akkreditierung ° Fremdleistung * außerhalb des Referenzbereiches

MEDIZINISCHES LABOR BREMEN

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH
Haferwende 12 · 28357 Bremen · Tel.: +49 (0) 421 2072-0 · Fax: +49 (0) 421 2072-167 · www.mlhb.de · info@mlhb.de

Dr. med. A. Gerritzen
Facharzt für Laboratoriumsmedizin
Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
Ärztlicher Leiter

Dr. med. A. Sputtek
Facharzt für Laboratoriumsmedizin
Facharzt für Transfusionsmedizin

Dr. med. V. Heisig
Facharzt für Laboratoriumsmedizin

Dr. med. S. Krell
Facharzt für Laboratoriumsmedizin
Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
Facharzt für Immunologie
Bluttransfusionswesen

Laura Maria Rodriguez
Fachärztin für Laboratoriumsmedizin
Fachärztin für Innere Medizin

Dr. med. D. Jacobsen
Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH · Haferwende 12 · 28357 Bremen

B2C

B2C STARNET - Direktlabor
(MLHB)
Haferwende 12

28357 Bremen

Teilbefund Seite: 2/3

Auftr.-Nr.: BP ZD01 1528

Patient: **BÖKER, MARCO**
geb.: 11.07.1981 M
Kasse: Privat

Material: NAF-BLUT,2xSERUM,EDTA
Entnommen: 01.04.26 11:00
Eingang: 01.04.26 11:05
Ausgang: 01.04.26
Ihre Nr.: **7705401316**

Bestimmung	Resultat			Referenzbereich
Kein Diabetes	< 100		mg/dl	
Abnormale Nüchternglukose (=IFG)	100 - 126		mg/dl	
Diabetes	> 126		mg/dl	

Quellen: DDG 2023: S3-Leitlinie Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle des Diabetes mellitus im Kindes- und Jugendalter; Praxisempfehlung der DDG 2023, Diabetol Stoffwechs 2023;18 (Suppl 2): S100-S113; doi:10.1055/a-2075-9943

Triglyceride	72		mg/dL	Zielwert	< 150
Cholesterin, ges.	162		mg/dL	Zielwert	< 200
HDL-Cholesterin	33	*	mg/dL	Zielwert	> 45
non-HDL-Cholesterin	129		mg/dL	Zielwert	< 145

In Abhängigkeit vom Risiko (Risikorechner SCORE2 http://www.scores.bnk.de/score2--2021-.html) gelten aktuell die folgenden Zielwerte:

Bei geringem Risiko: < 145 mg/dL, bei moderatem Risiko: < 130 mg/dL, bei hohem Risiko: < 100 mg/dL, bei sehr hohem Risiko: < 85 mg/dL.

LDL-Cholesterin	115		mg/dL	Zielwert	< 115

In Abhängigkeit vom Risiko (Risikorechner SCORE2 http://www.scores.bnk.de/score2--2021-.html) gelten aktuell die folgenden Zielwerte:
Bei geringem Risiko: < 115 mg/dL, bei moderatem Risiko: < 100 mg/dL, bei hohem Risiko: < 70 mg/dL, bei sehr hohem Risiko: < 55 mg/dL.

TSH i. S.	0.68		mU/L	Euthyreose	0.27 - 4.20
				Hyperthyreose	< 0.05
				Graubereich	0.05 - 0.27
				Prim. Hypoth.	> 4.20

Messmethode: ECLIA
Die Diagnose einer latenten Hypothyreose wird i. d. R. bei wiederholter Messung eines TSH-Wertes über 4,0 mU/L bei normwertigem fT4 gestellt. (Dtsch. Ärztebl. 2017;114:430). Im Falle einer L-Thyroxin-Supplementationstherapie sollten i. d. R. Werte zwischen 0,4 und 4,0 mU/L angestrebt werden (DEGAM Leitlinie S2k).

Trijodthyronin, frei (FT3)	2.71		ng/L	2.0 - 4.4
Thyroxin, frei (FT4)	6.3	*	ng/L	9.2 - 16.8
Prolaktin i. S.	0.9	*	µg/L	4.0 - 15.2

´Außerhalb der Akkreditierung ° Fremdleistung * außerhalb des Referenzbereiches

MEDIZINISCHES LABOR BREMEN

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH
Haferwende 12 · 28357 Bremen · Tel.: +49 (0) 421 2072-0 · Fax: +49 (0) 421 2072-167 · www.mlhb.de · info@mlhb.de

Dr. med. A. Gerritzen
Facharzt für Laboratoriumsmedizin
Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
Ärztlicher Leiter

Dr. med. A. Sputtek
Facharzt für Laboratoriumsmedizin
Facharzt für Transfusionsmedizin

Dr. med. V. Heisig
Facharzt für Laboratoriumsmedizin

Dr. med. S. Krell
Facharzt für Laboratoriumsmedizin
Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
Facharzt für Immunologie
Bluttransfusionswesen

Laura Maria Rodriguez
Fachärztin für Laboratoriumsmedizin
Fachärztin für Innere Medizin

Dr. med. D. Jacobsen
Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie

Teilbefund Seite: 3/3

Auftr.-Nr.: BP ZD01 1528

Patient: **BÖKER, MARCO**
geb.: 11.07.1981 M
Kasse: Privat

Material: NAF-BLUT,2xSERUM,EDTA
Entnommen: 01.04.26 11:00
Eingang: 01.04.26 11:05
Ausgang: 01.04.26
Ihre Nr.: **7705401316**

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH · Haferwende 12 · 28357 Bremen

B2C

B2C STARNET - Direktlabor
(MLHB)
Haferwende 12

28357 Bremen

Bestimmung	Resultat			Referenzbereich
Messmethode: ECLIA				
17ß-Oestradiol i. S.	99	*	ng/L	11 - 43
Dieser Test ist nicht zur Estradiol-Bestimmung bei Patienten geeignet, die mit Fulvestrant® behandelt werden (mögliche Kreuzreaktivität).				
IGF-1 (Somatomedin C)	301	*	µg/L	78.7 - 226.0
IGF-1: Die angegebenen altersabhängigen Referenzbereiche entsprechen der 2.5 bis 97.5 Perzentile. Erhöhte IGF-1 Konzentration. V.a. Wachstumshormonexzess. Ggf. HGH-Suppressionstest (OGTT).				
HOMA-Index	0.9			
Der HOMA-Index (Homeostasis Model Assessment) ist ein Maß der Insulinresistenz; seine Berechnung ist nur aus nüchtern gewonnenem Blut in NaF- oder GlucoEXACT-Röhrchen sinnvoll. HOMA-IR Werte >1.9 sind mit einem deutlich erhöhten Risiko für das metabolische Syndrom assoziiert. Niedrigere HOMA-IR Werte schließen jedoch ein metabolisches Syndrom nicht aus.				
Insulin i. S.	4.0		mU/L	2.6 - 24.9

Validiert am 01.04.2026 um 18:33 Uhr. Verantwortlicher Arzt: Dr. Sputtek

´Außerhalb der Akkreditierung ° Fremdleistung * außerhalb des Referenzbereiches